

Bệnh Peyronie

WARWIKI

Thông tin cho bệnh nhân · Mô sẹo làm cong dương vật — và cách điều trị

Bệnh Peyronie là tình trạng một mảng mô sẹo (**màng xơ**) hình thành trong thành dương vật, khiến dương vật bị **cong, thu hẹp, lõm vào, hoặc ngăn lại**, đôi khi kèm đau khi cương. Bệnh có thể khiến quan hệ tình dục khó khăn. Đây là bệnh phổ biến, **không phải ung thư**, và có phương pháp điều trị hiệu quả — lựa chọn phù hợp tùy thuộc vào giai đoạn bệnh.

Về tình trạng này

Bệnh Peyronie thường trải qua hai giai đoạn:

- **Giai đoạn hoạt động (cấp tính)** — độ cong đang thay đổi và có thể đau, thường kéo dài 6–18 tháng.
- **Giai đoạn ổn định** — độ cong và màng xơ đã ổn định, cơn đau thường giảm.

Lựa chọn điều trị phụ thuộc vào giai đoạn bạn đang ở, vì vậy nhóm chăm sóc sẽ hỏi về sự thay đổi theo thời gian.

Nguyên nhân

Bệnh được cho là do những chấn thương nhỏ khi uốn cong dương vật trong quan hệ tình dục, lành lại bằng sẹo bất thường thay vì mô bình thường. Bệnh thường gặp hơn ở người cao tuổi, người bị tiểu đường, sau phẫu thuật tuyến tiền liệt, và ở nam giới cũng có **co rút Dupuytren** (tình trạng sẹo tương tự ở bàn tay).

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Bệnh Peyronie

Mô sẹo trong dương vật gây cong hoặc biến dạng.

Màng xơ

Vùng mô sẹo gây ra sự cong.

Hoạt động và ổn định

Độ cong còn thay đổi hay đã ổn định.

Liệu pháp kéo căng

Thiết bị kéo nhẹ dương vật để cải thiện độ cong và chiều dài.

Collagenase (Xiaflex)

Thuốc tiêm vào màng xơ để làm tan màng.

Khâu gấp / ghép mảnh

Các phương pháp phẫu thuật để làm thẳng dương vật.

CÓ CẦN PHẪU THUẬT NGAY KHÔNG? Thường là không. Trong **giai đoạn hoạt động**, độ cong vẫn đang thay đổi, nên trọng tâm là giảm đau và các phương án không phẫu thuật. Phẫu thuật chỉnh thẳng được đề nghị khi tình trạng đã **ổn định** (thường sau khi độ cong không đổi và cơn đau đã giảm). Nhiều bệnh nhân cải thiện mà không cần phẫu thuật.

Chẩn đoán như thế nào

- Hỏi về lịch sử độ cong, cơn đau và sự thay đổi theo thời gian
- Khám để sờ màng xơ; đôi khi chụp ảnh khi cương hoặc đánh giá tại phòng khám
- Đôi khi siêu âm để xác định vị trí màng xơ và lưu lượng máu

Điều trị như thế nào (theo giai đoạn)

- 1 **Giai đoạn hoạt động** — trấn an, kiểm soát đau, thường dùng **liệu pháp kéo căng**; mục tiêu là hạn chế tiến triển xấu hơn.
- 2 **Tiêm vào màng xơ** — thuốc như **collagenase (Xiaflex)** tiêm trực tiếp vào màng xơ để giảm độ cong.
- 3 **Phẫu thuật (giai đoạn ổn định)** — **khâu gấp** (khâu phía dài hơn; đơn giản nhất, có thể làm ngắn dương vật) hoặc **rạch màng xơ/ghép mảnh** (giữ nguyên chiều dài, dành cho cong nặng).
- 4 **Bộ phận giả dương vật** — nếu kèm theo rối loạn cương dương. Mỗi lựa chọn có tờ thông tin riêng.

Cần biết

- Đứng cố “nắn thẳng” bằng tay — có thể làm tổn thương nặng hơn.
- Độ cong không cản trở quan hệ có thể chỉ cần theo dõi.
- Bệnh Peyronie có thể ảnh hưởng tâm lý và quan hệ — hỗ trợ tinh thần rất quan trọng.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Độ cong **cản trở quan hệ tình dục**, hoặc cong ngày càng nặng hơn
- **Đau** nhiều khi cương
- **Rối loạn cương dương (rối loạn cương dương)** mới xuất hiện cùng với sự cong

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Bệnh Peyronie là mô sẹo làm cong dương vật — phổ biến, không phải ung thư, và có thể điều trị.
2. Điều trị tùy theo giai đoạn: giảm đau và không phẫu thuật khi đang hoạt động; can thiệp chỉnh thẳng khi đã ổn định.
3. Nhiều bệnh nhân cải thiện không cần phẫu thuật. Hãy gặp nhóm chăm sóc nếu cong cản trở quan hệ, đau kéo dài, hoặc có rối loạn cương dương mới.